



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

证券研究报告

2021年8月1日

聚焦成长性，寻找向上变化的个股

国泰君安医药行业2021年8月投资策略

行业评级：增持

姓名：丁丹（分析师）

邮箱：dingdan@gtjas.com

证书编号：S0880514030001

姓名：赵峻峰（分析师）

邮箱：zhaojunfeng@gtjas.com

证书编号：S0880519080017

姓名：于嘉轩（分析师）

邮箱：yujiaxuan@gtjas.com

证书编号：S0880519080014

姓名：张祝源（分析师）

邮箱：zhangzhuyuan@gtjas.com

证书编号：S0880519090001

姓名：黄炎（分析师）

邮箱：huangyan@gtjas.com

证书编号：S0880521070001

姓名：吴宇擎（分析师）

邮箱：wuyuqing@gtjas.com

证书编号：S0880516050001

投资要点（行业评级：增持）

01

中报前瞻：重点公司业绩良好，预计符合预期为主

从医院终端市场看，2021年以来虽然门诊较2019年有增长，但病床使用率尚未恢复至2019年疫情前的水平，但重点上市公司的业绩明显好于行业，展现了龙头公司的经营韧性和对市场份额的虹吸效应。我们再次强调，随着疫情影响导致的2020年低基数效应逐季减弱以及其他消费&出口产业可能的变化，A股整体盈利压力之下，医药板块“内循环+强刚需”所带来的增长持续性优势将进一步凸显。

02

高估值下政策影响放大波动

经历了4-6月上涨，7月初医药高景气板块短期估值已经较高，此时市场对负面变量尤其敏感，过度解读有关政策放大情绪波动。如7月初CDE抗肿瘤药临床试验政策对创新药和CXO的影响、以及7月底教培双减政策对民营医疗服务的牵连。目前医疗服务板块估值已从7月初的2021PE 110+X（wind一致预期整体法）降至7月底2021PE 90X+、2022PE 70X+，短期内消费属性医疗股或许还会受到政策不确定预期的情绪影响，产业中长期发展无虞。（注：SW行业分类中主要CXO公司也计入医疗服务子板块）

03

8月中报密集披露期聚焦业绩高增长&确定性，同时寻找向上变化的个股

①业绩高增长&确定性高：迈瑞医疗、药明康德、康龙化成、昭衍新药、爱尔眼科、通策医疗、智飞生物、爱美客；②下半年看个股向上变化：我武生物、康泰生物、开立医疗。



目录 / CONTENTS

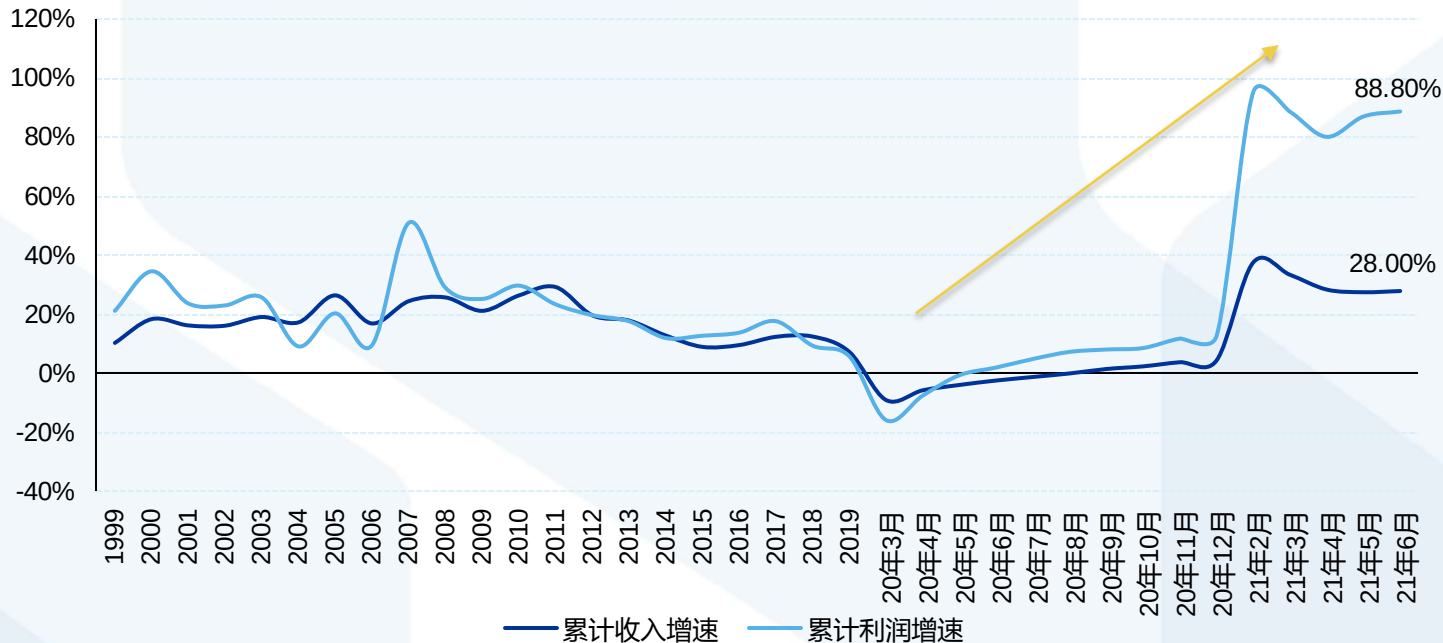
01 2021年中报及下半年展望：增长优势凸显

02 政策再次密集影响，但估值高更是调整主因

03 重点个股盈利预测和估值

医药工业恢复良好，1-6月利润增速低基数高增长

2021年1-6月医药制造业利润同比显著改善



医药板块下半年业绩增长优势将进一步凸显

- **和2019年比，龙头公司远好于行业：**从医院终端市场看，2021年以来虽然门诊较2019年有增长，但病床使用率尚未恢复至2019年疫情前的水平，但重点上市公司的业绩明显好于行业，展现了龙头公司的经营韧性和对市场份额的虹吸效应。
- **和2020年比：Q2增速因基数原因放缓：**虽然因基数原因2021Q2同比增速较Q1有所放缓，但预计多数公司继续保持强劲恢复增长。需注意：部分订单生产型公司如CDMO因2020Q1产能有1-1.5个月影响，2020Q2追回产能而基数较高；可择期医疗也因2020Q1的医疗消费延后至Q2集中完成，亦形成去年同期较高基数——增速放缓只是因上述原因在季节间的阶段性波动，并不代表公司本身的经营趋势。
- **和2021上半年相比，预计下半年：**景气度继续高企的是CXO、医美、不可择期医药产品、医疗服务；景气度继续恢复的是部分可择期医疗产品；景气度出现新气象的是疫苗板块。
- **2021下半年医药行业逐季展现横向比较优势。**“根据最新实际盈利数据与宏观预测数据，我们的盈利预测结果显示2021四季度面临负增长的压力。（引用自国泰君安策略报告《向死而生，四季度盈利负增长压力有多大》）”。随着疫情影响导致的2020年低基数效应逐季减弱，A股整体盈利压力之下，医药板块“内循环+强刚需”所带来的增长持续性优势将进一步凸显。



预计医药重点上市公司中报表现良好

≥100%及以上：爱美客、智飞生物、通策医疗、昭衍新药、九洲药业、昊海生科；

≥50%：泰格医药、开立医疗、心脉医疗、药明康德（non-IFRS）、康龙化成（non-IFRS）、金域医学、安图生物、迈克生物、爱尔眼科、博腾股份；

40%~50%：凯莱英、健帆生物、普门科技；

30%~40%：艾德生物、我武生物、华熙生物、威高骨科；

20%~30%：丽珠集团、健康元、康泰生物、迈瑞医疗、大博医疗、益丰药房、一心堂、大参林、威高股份、片仔癀、国药一致、云南白药（扣非）；

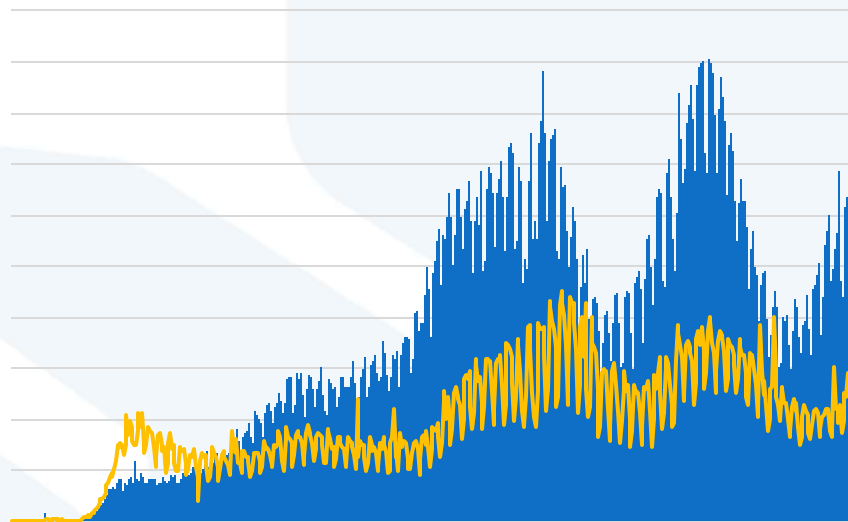
10%~20%：老百姓、天坛生物、恒瑞医药；

0%~10%：华兰生物。

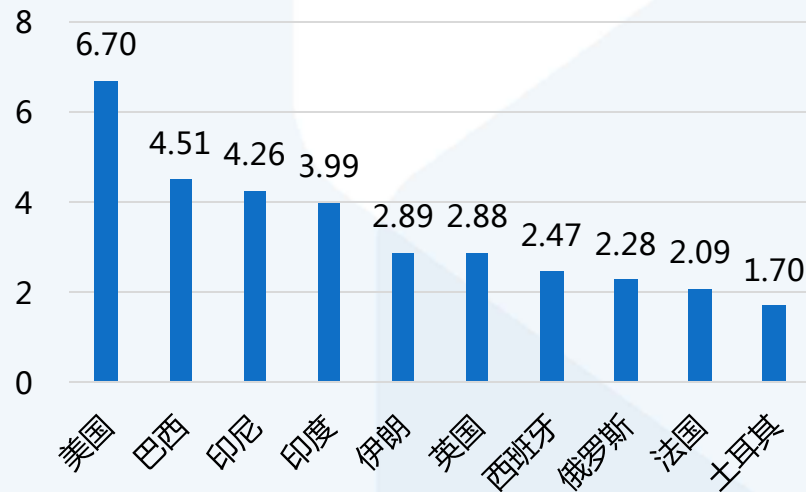


新冠疫情：近期全球疫情有所反弹

近期全球每日新增确诊病例数有所回升



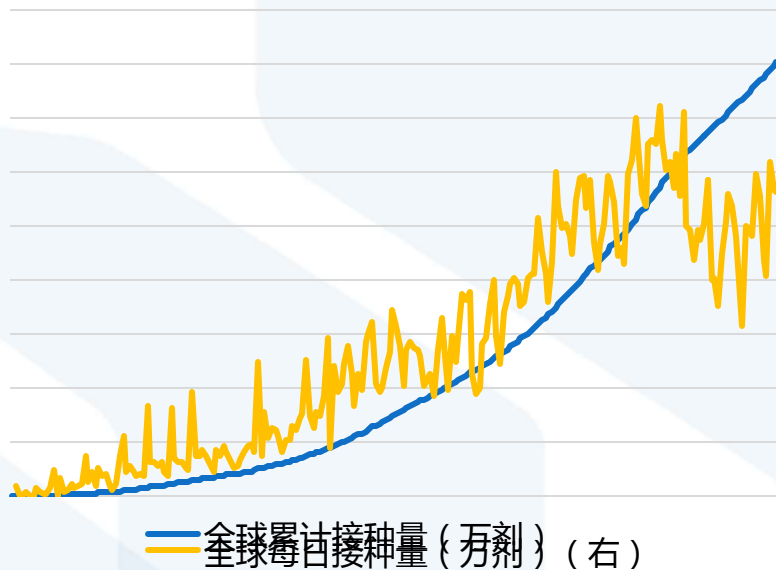
多国每日新增确诊病例仍在万人以上



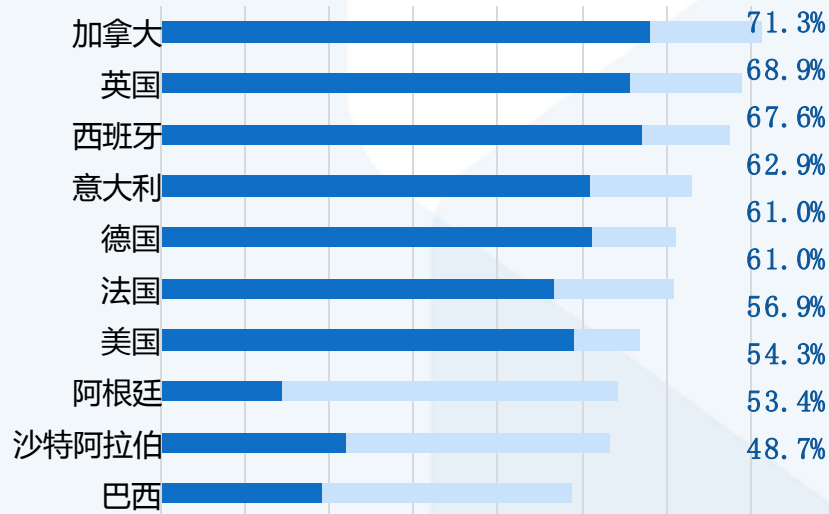
■ 七日内平均每日新增确诊病例数 (万例)

新冠疫苗：全球接种快速推进

全球新冠疫苗接种量已突破40亿剂



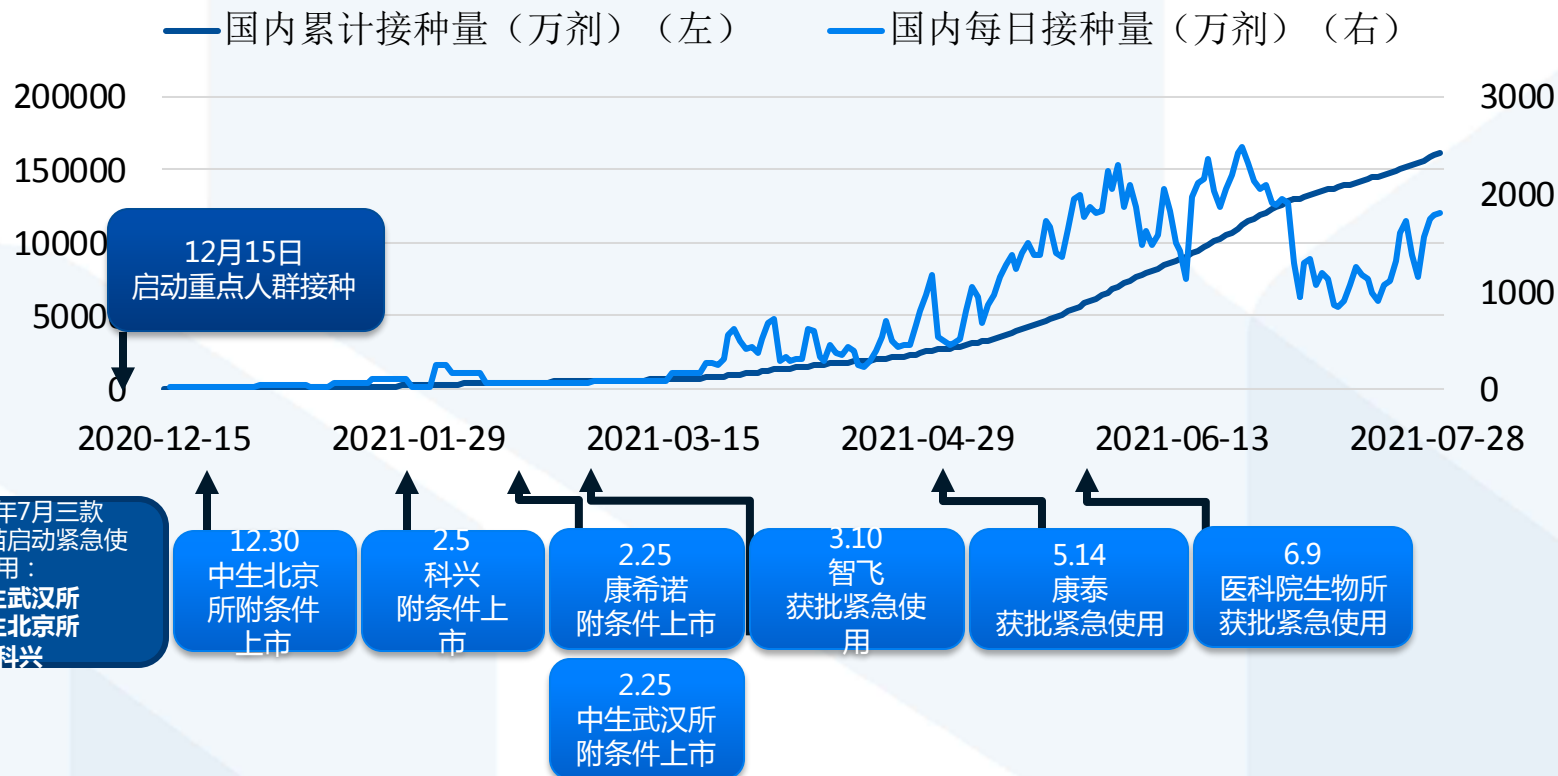
多国基础免疫推进顺利



注：仅部分国家披露了具体的新冠疫苗接种数据

新冠疫苗：国内已接种新冠疫苗超过16亿剂次

截至2021年7月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗161921.8万剂次。



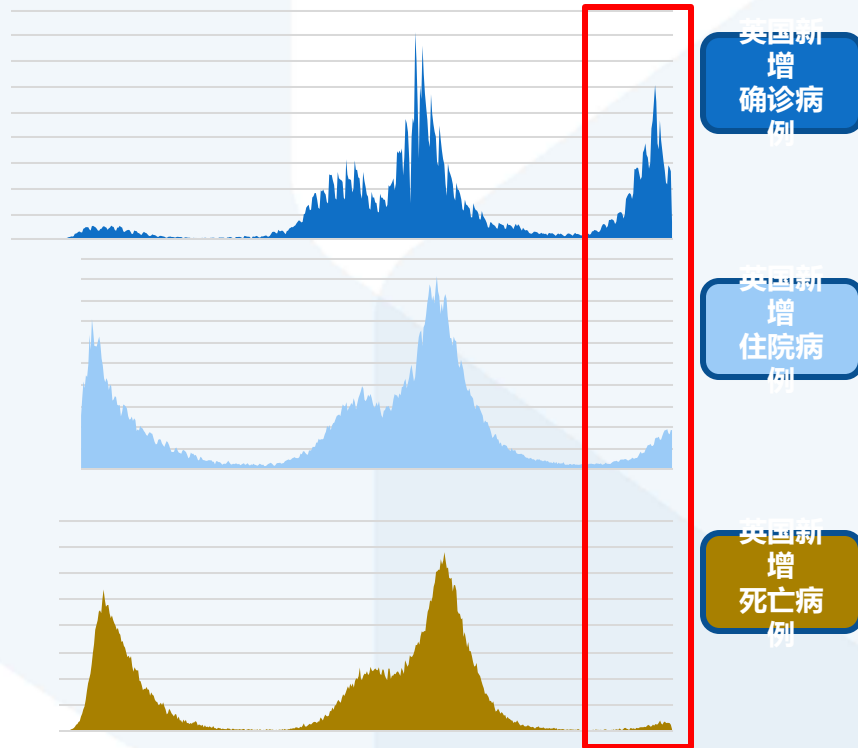
新冠疫苗：针对变异株仍有效果，有效降低死亡/重症/住院比例

现有疫苗针对Delta变异株仍有较好效果

疫苗		针对Delta变异株的效果
国内	中国生物	➢ 接种者血清能够交叉中和Delta变异株*
	科兴	➢ 接种者血清能够交叉中和Delta变异株*
	智飞	➢ (0,1m,2m) 接种程序下假病毒中和活性相比原始型 下降1.4倍 ；(0,1m,4m-6m) 接种程序下假病毒中和活性相比原始型 未下降
海外	辉瑞/BioNTech	➢ 英国真实世界研究显示，全程免疫2周后，有症状保护效力 88%
	Moderna	➢ 中和活性较原始毒株 下降2.1倍
	阿斯利康	➢ 英国真实世界研究显示，全程免疫2周后，针对Delta变异株有症状保护效力 67% （Alpha突变株为75%）；
		➢ 加拿大真实世界研究显示，单针接种对Delta突变株感染的有症状保护效力为 70% （Alpha变异株为72%，Beta/Gamma变异株为50%），住院和死亡保护效力为 87% （Alpha变异株为90%，Beta/Gamma变异株为82%）
	强生	➢ 假病毒中和活性相比原始型下降1.6倍
	Sputnik V	➢ 接种者血清能够交叉中和Delta变异株*
	Bharat Biotech	➢ 与生产用的原始毒株相比，中和活性 下降1.95倍 ； ➢ 针对Delta变异株保护效力 65.2%

*尚未披露详细数据

英国本轮疫情住院、死亡病例显著下降



新冠疫苗：商业化顺利，业绩可期

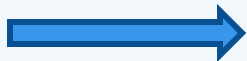
	生产厂家	接种程序	产能订单			在手订单*	新冠疫苗业绩					
			21年产能	22年产能	21年产能释放节奏		21Q1收入	21Q2收入	21H1收入	21H1净利润	21全年预计收入	平均单价
国内	中国生物	2针	50亿	50亿	3月26日累计供应全球1亿剂，4月份开始每月供应1亿剂，6月底北京所第三个P3生产车间建成投产	2.4亿	/	/	/	/	/	/
	科兴	2针	20亿	20亿	4月1日全球累计发货2亿剂，4月28日全球累计发货3亿剂，5月31日全球累计发货超6亿剂	9.6亿	净利润约90亿元**	/	/	/	/	每支净利润约50元**
	康希诺	1针	5-7亿	5-7亿	/	0.8亿	/	/	~21亿元	~9.75亿元	/	/
	智飞	3针	3-6亿（原液10亿）	3-6亿（原液10亿）	/	/	/	/	/	/	/	/
	康泰	2针	2亿（原液5-6亿）	2亿（原液5-6亿）	/	/	/	/	/	/	/	/
	国内合计（亿支） 对应人口（亿人）		80-85 42-45	80-85 42-45								
海外	辉瑞/BioNTech	2针	30亿	30亿	1月31日累计发货6500万剂，5月6日累计发货约4.5亿剂，7月28日累计发货超过10亿剂	31.6亿	34.6亿美元	78.38亿美元	~113亿美元	/	335亿美元	15.95美元
	Moderna	2针	8-10亿	30亿	20Q4发货1300万剂，21Q1发货1.02亿剂，21Q2预计发货2-2.5亿剂	16.3亿	17.3亿美元	/	/	/	192亿美元	16.96美元
	强生	1针	10亿	10亿	/	8.9亿	1亿美元	1.64亿美元	2.64亿美元	/	25亿美元	至多8美元（非盈利）
	阿斯利康	2针	21亿	21亿	21Q1发货6800万剂，21H1共发货3.19亿剂	32.4亿	2.75亿美元	8.94亿美元	11.69亿美元	/	/	3.66美元
	俄罗斯Sputnik V	2针	4亿	4亿	/	4.7亿	/	/	/	/	/	低于10美元
	Bharat Biotech	2针	10亿	10亿	6月15日累计发货超过4000万剂	11.3亿	/	/	/	/	/	2美元（国内） 15-20美元（海外）
	海外合计（亿支） 对应人口（亿人）		83-85 46.5-47.5	105 57.5								
	全球合计（亿支） 对应人口（亿人）		163-170 88.5-92.5	185-190 99.5-102.5								

*杜克大学根据各公司公开披露的订单数据统计，截至7月23日；**科兴Q1净利润数据根据中国生物制药披露的21Q1联营及合营公司利润估算（中国生物制药持股科兴中维）

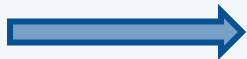
或与新冠病毒长期共存，新冠疫苗需求有望持续



更多研究证据显示新冠疫苗
效果或随时间而下降



研究显示加强针能
提高中和抗体水平
(科兴、辉瑞.....)



可能需要针对新变异株
开发新的疫苗



加强针需求或将
长期存在
(类似流感疫
苗)



Delta变异株蔓延
未来出现新变异株的可能性增大

策略一：针对变异株的加强针

- 将生产用毒株更换为变异株（灭活路线）或将基因片段序列改为变异株序列（mRNA、腺病毒载体、重组蛋白亚单位等路线），生产针对某种变异株的加强针。
- 例：Moderna的mRNA-1273.351（针对Beta变异株设计），阿斯利康的AZD-2816（针对Beta变异株设计）

策略二：多价苗

- 加强针同时含有针对多种新冠病毒株设计的疫苗成份，能同时对多种毒株产生较好保护效果
- 例：Moderna正在开展将等量的mRNA-1273和mRNA-1273.351混合接种的临床研究

策略三：优化接种程序 不同疫苗序贯接种

- 不同类型疫苗序贯接种可提高免疫反应的广度、强度、持久性和功能性
- 例：我国正在开展用Ad5腺病毒载体疫苗进行初免，用重组蛋白疫苗或灭活疫苗进行加强；或灭活新冠疫苗进行初免，Ad5腺病毒载体新冠疫苗或mRNA新冠疫苗进行加强的临床研究



目录 / CONTENTS

01 2021年中报及下半年展望：增长优势凸显

02 政策再次密集影响，但估值高更是调整主因

03 重点个股盈利预测和估值

7月初CDE《抗肿瘤药物临床研发指导原则》——创新药研发需要的边际思维



区别于市场观点：

我们认为该文件是拟将行业中已经在实践执行的标准落地为法规文件，而非对行业进行超前拔高要求：短期对行业内头部企业没有影响；长期看，给真正有价值的创新释放出更多的资源，避免重复研发带来的同质化竞争，利好行业长期发展。

中国临床试验进入2.0时代

中国的角色在变

自2017年中国加入ICH以来，将从施行ICH标准走到参与讨论和制定标准，注定着中国的临床试验标准终将与国际看齐。

监管的关注点在变

自722事件以来，监管已经从关注临床试验的操作规范和数据真实度，到如今的关注临床试验的临床价值。

速度和真创新是创新药核心竞争力

治疗标准水涨创高，更需临床获益边际思维

考虑到新疗法获批不断刷新患者最优生存获益，“速度”依旧是创新药企获得先机的关键竞争要素。有效性之外，还有安全性、顺应性、非富集人群、和药物经济学等差异化方向。

对照选择需谨慎，创新方能突破

对照的选择更趋严谨，me-too类药物的生存空间受挤压，受益有充分基础研究的me-better药物及新作用机制的first-in-class药物。



对照组的選擇：參照FDA經驗，對照更傾向於選擇標準療法

- 應盡量為受試者提供臨床實踐中最佳治療方式/藥物，而不應為提高臨床試驗成功率和試驗效率，選擇安全有效性不確定，或已被更優的藥物所替代的治療手段。
- 另一方面，新葯研發應以為患者提供更優的治療選擇為最高目標，**當選擇非最優的治療作為對照時，即使臨床試驗達到預設研究目標，也無法說明試驗葯物可滿足臨床中患者的實際需要，或無法證明該葯物對患者的價值**
- 當選擇陽性葯作為對照時，應關注陽性對照葯是否反映和代表了目標適應症患者最佳用葯情況；當計劃選擇安慰劑或 BSC 作為對照葯時，則應確保該適應症在臨床中確無標準治療。

——《以臨床價值為導向的抗腫瘤葯物臨床研發指導原則》徵求意見稿

Bcr-Abl 抑制劑	通用名	FDA首次獲批	慢性期Ph+ CML的一線治療		
			獲批時間	試驗設計	結果
第一代	imatinib	2001年	2003年	Imatinib vs IFN+Ara-C	證明優效
第二代	dasatinib	2006年	2010年	dasatinib vs imatinib	證明優效
第二代	nilotinib	2007年	2010年	nilotinib vs imatinib	證明優效
第二代	bosutinib	2012年	2017年	bosutinib vs imatinib	NA
第三代	ponatinib	2012年	無該適應症	--	--

EGFR-TKI	通用名	FDA首次獲批	EGFR突變的NSCLC一線治療		
			獲批時間	試驗設計	結果
第一代	吉非替尼	2003年	2015年	吉非替尼 vs 標準化療	非劣效試驗，最終證明優效
第一代	厄洛替尼	2004年	2013年	厄洛替尼 vs 標準化療	
第二代	阿法替尼	2013年	2013年	阿法替尼 vs 標準化療	證明優效
第三代	奧希替尼	2015年	2018年	奧希替尼 vs 標準EGFR-TKI(吉非或厄洛)	

■ 選擇標準療法，而不一定選擇“最優療法”，指南的推薦等級可作為參考

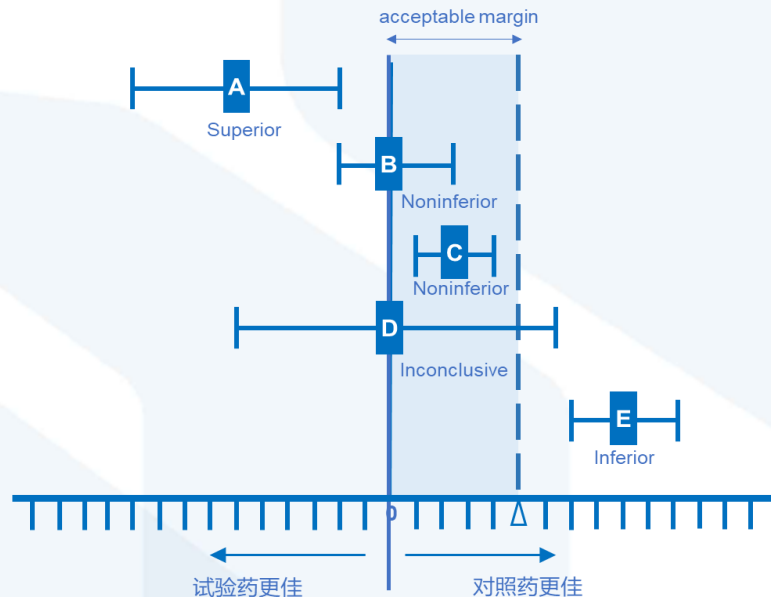
- 雖然二代相對於一代，已經展現出優效，但在NCCN指南中，同為1類推薦，並無區分優劣
- Bosutinib在2017年獲批一線CML適應症時，仍採取伊馬替尼作為對照

- 吉非替尼和奧希替尼，雖然設置的對照組不同，但皆為當時的標準療法

试验方案的选择：采用非劣效设计需具备一定的前提

非劣效试验的定义：

主要研究目的是证明试验药疗效在临床意义上不差于阳性对照药，需在设计试验方案时确定好margin。margin可理解为“疗效差异的判断界值”，即临床上所能接受的、对阳性对照的有效性损失最大区间。



非劣可被接受的情形：舍弃一定疗效时，获得其他优势

- 新疗法费用更低
- 新疗法毒性更低
- 新疗法疗程更少
- 新疗法给药更方便

实施非劣效试验的主要原因

■ 对照组设置安慰剂无法符合伦理

若该适应症已有药物获批，应该给入组患者提供目前能提供临床获益的药物。非劣效试验的主要目的，不是“比不吃药好”，而是“具有可接受的疗效”。

非劣效试验的结果具有临床意义，需具备2个条件

■ margin的正确选择：

参考历史阳性对照vs安慰剂实验结果；无明确标准；临床意义大于数统意义；不宜过大或过小

■ 阳性对照展现出有效性：

其结果于之前的安慰剂对照具有一致性

FDA对非劣效的态度：接受，但案例有限

- 非劣的设计是被允许的，2016年发布《Non-Inferiority Clinical Trials to Establish Effectiveness--Guidance for Industry》
- **案例1：**FDA批准利妥昔单抗与糖皮质激素联用，用于韦格纳肉芽肿病和多血管炎，该疗法非劣效于环磷酰胺
- **案例2：**FDA批准希罗达单药用于杜克式C期结直肠癌，非劣于5-FU+亚叶酸



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信·责任·亲和·专业·创新

数据来源：Pubmed，FDA，国泰君安证券研究

请参阅附注免责声明 16

医疗服务：政策持续支持社会办医，产业趋势不变

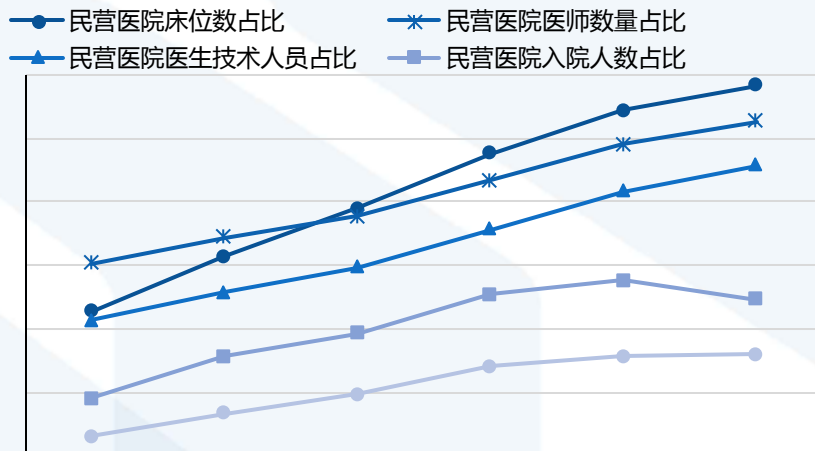
- 医疗和教育的类似点包括同样涉及民生、同样涉及公办VS社会办。但医疗和教培的情况有本质不同——根据十四五规划阐述：对校外培训是“规范”，对社会办医是“支持”，我们认为顶层政策是基于真实国情民情的精准调控，而**医疗明显仍处于供给不足的现状，预计会继续支持社会办医。**

发布时间	文件名称	发布单位	指导内容
2016年10月25日	《“健康中国2030”规划纲要》	国务院	优化多元办医格局，进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒。加大政府购买服务的力度，支持保险业投资、设立医疗机构，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。加强政府监管、行业自律与社会监督，促进非公立医疗机构规范发展。
2017年1月10日	《“十三五”卫生与健康规划》	国务院	大力发展社会办医。鼓励社会力量兴办健康服务业，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会力量办医预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。放宽社会力量举办医疗机构的服务领域要求，支持社会力量以多种形式参与健康服务。发展专业性医院管理集团，推动社会力量办医疗机构上水平发展。鼓励社会力量发展儿科、精神科、老年病、长期护理、口腔保健、康复、安宁疗护等资源稀缺及满足多元需求的服务。
2017年5月23日	《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》	国务院	瞄准供需矛盾突出领域，以先进技术、特色服务、品牌质量为重点，充分释放社会办医潜力和活力，促进人才、资金、技术等要素合理流动、充分发展，推动社会办医服务创新、业态升级，与政府办医共同发展、有序竞争。加大力度消除社会办医的体制机制障碍，降低准入门槛，简化审批流程，提高审批效率。对社会办医疗机构在准入、执业、监管等方面与公立医疗机构一视同仁，营造公平竞争环境，促进社会力量踊跃提供多层次多样化医疗服务。
2019年2月19日	《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》	发改委等18部门	促进社会办医加快发展。支持社会力量举办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。
2019年6月12日	《关于促进社会办医持续健康发展的意见》	国家卫健委等十部门	以深化“放管服”改革为主线，从加大政府支持力度、简化审批服务、公立医疗机构与社会办医分工合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策、完善综合监管体系等6个方面入手，提出22项政策措施，加大对社会办医的鼓励扶持和促进规范发展的力度。
2019年12月28日	《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》	十三届全国人大常委会第十五次会议	鼓励社会力量举办的医疗卫生机构提供基本医疗服务。国家采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。社会力量可以选择设立非营利性或者营利性医疗卫生机构。
2021年3月11日	《“十四五”规划》	十三届全国人大四次会议	深化医药卫生体制改革，坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给；支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。
2021年6月17日	《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》	国务院	推动优质医疗资源扩容和均衡布局；积极支持社会办医发展；社会办医疗机构可牵头组建或参加县域医共体和城市医疗集团。

医疗服务：民营占比仍低，具备较大差异化发展空间

- 未来社会办医真正基于临床需求的有效补充才能获得可持续发展，在医疗资源薄弱区域、在高端医疗需求旺盛的细分专科市场、在公立医院因自身原因不善发展的领域，社会办医仍面临较大的差异化发展空间。
- 2019年2月，发改委等18部门联合发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量，促进形成强大国内市场的行动方案》，支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。

民营医院卫生资源以及医疗服务指标占比持续提升，但总量占比较低



民营医院卫生资源近年发展速度快于公立医院

项目	民营医院		公立医院	
	2019年	CAGR (2014- 2019)	2019年	CAGR (2014- 2019)
床位数 (张)	1,890,913	17.7%	4,975,633	3.8%
诊疗人数 (万人)	57,008	11.9%	327,232	4.3%
入院人数 (万人)	3,696	13.5%	17,487	5.4%
卫生技术人员 (人)	2,407,351	14.2%	7,736,659	4.1%
医师数量 (人)	827,171	12.8%	2,383,344	4.4%

高值耗材：骨科创伤带量采购降幅基本符合预期，关注后续以量换价

- 普通接骨板平均终端降幅87.05%，稳定加压接骨板系统（含万向）平均降幅89.45%，髓内钉系统平均降幅89.12%，预计对出厂价有所伤及；
- 威高骨科、大博医疗、三友医疗、微创骨科、迈瑞骨科等公司创伤产品普遍中标，中标率较高，关注后续以量换价情况。

申报企业	一级目录	二级目录	平均拟中选价	二级目录基准价	基准价基础上的平均降幅
微创骨科	髓内钉系统	股骨髓内钉	1494.8	11687.2	87%
微创骨科	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1161.5	9359.7	88%
威高骨科	普通接骨板系统	桡骨接骨板	308.6	4683.6	93%
威高骨科	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	880.6	9359.7	91%
威高海星（威高骨科子公司）	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1161.5	9359.7	88%
健力邦德（威高骨科子公司）	普通接骨板系统	桡骨接骨板	444.0	4683.6	91%
健力邦德（威高骨科子公司）	髓内钉系统	股骨髓内钉	1494.8	11687.2	87%
健力邦德（威高骨科子公司）	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1161.5	9359.7	88%
三友医疗	普通接骨板系统	桡骨接骨板	808.4	4683.6	83%
三友医疗	髓内钉系统	股骨髓内钉	1293.8	11687.2	89%
三友医疗	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1099.8	9359.7	88%
迈瑞骨科	普通接骨板系统	桡骨接骨板	557.8	4683.6	88%
迈瑞骨科	髓内钉系统	股骨髓内钉	1269.2	11687.2	89%
迈瑞骨科	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	798.4	9359.7	91%
江苏艾迪尔（凯利泰子公司）	髓内钉系统	股骨髓内钉	1430.0	11687.2	88%
江苏艾迪尔（凯利泰子公司）	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1160.0	9359.7	88%
大博医疗	普通接骨板系统	桡骨接骨板	619.2	4683.6	87%
大博医疗	髓内钉系统	股骨髓内钉	1159.1	11687.2	90%
大博医疗	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	897.6	9359.7	90%
博益宁（大博子公司）	普通接骨板系统	桡骨接骨板	798.0	4683.6	83%
博益宁（大博子公司）	髓内钉系统	股骨髓内钉	1288.0	11687.2	89%
博益宁（大博子公司）	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	1161.6	9359.7	88%
北京理贝尔（爱康医疗子公司）	普通接骨板系统	桡骨接骨板	208.7	4683.6	96%
北京理贝尔（爱康医疗子公司）	髓内钉系统	股骨髓内钉	523.9	11687.2	96%
北京理贝尔（爱康医疗子公司）	锁定加压接骨板系统（含万向）	胫骨接骨板	394.8	9359.7	96%

目录 / CONTENTS

01 2021年中报及下半年展望：增长优势凸显

02 政策再次密集影响，但估值高更是调整主因

03 重点个股盈利预测和估值

医药板块相对估值溢价已出现回落

- 疫情以来，医药板块绝对收益和相对收益均较为突出，此后2020年9月以及2021年2月曾出现过两次显著的估值收敛，彼时曾回落至相对全部A股估值溢价130%左右的阶段性底部区间。自2021年7月以来，医药板块的估值已出现明显回落，目前整个医药板块对应2021年预测PE38X；医药板块相对于全部A股估值溢价率163%，正在接近中枢水平。

市盈率：医药VS.全部A股



市盈率溢价：医药VS.全部A股



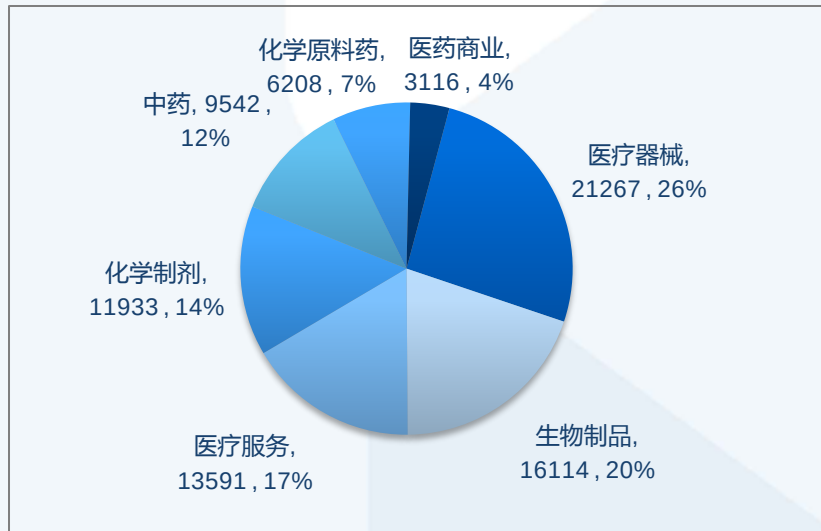
数据来源：wind，国泰君安证券研究，注：数据截至2021-7-30

7月医疗服务受政策影响调整明显，但估值低的子行业整体调整更大

A股医药板块7月跌幅较大

板块	2021预测PE(整体法) 2021-08-01	2021预测PE(整体法) 2021-07-01	7月估值跌幅
医疗服务	94	113	-16%
生物制品	48	50	-5%
医药生物	39	43	-11%
化学原料药	36	37	-5%
医疗器械	35	37	-6%
化学制剂	31	39	-21%
中药	29	34	-16%
医药商业	15	16	-7%

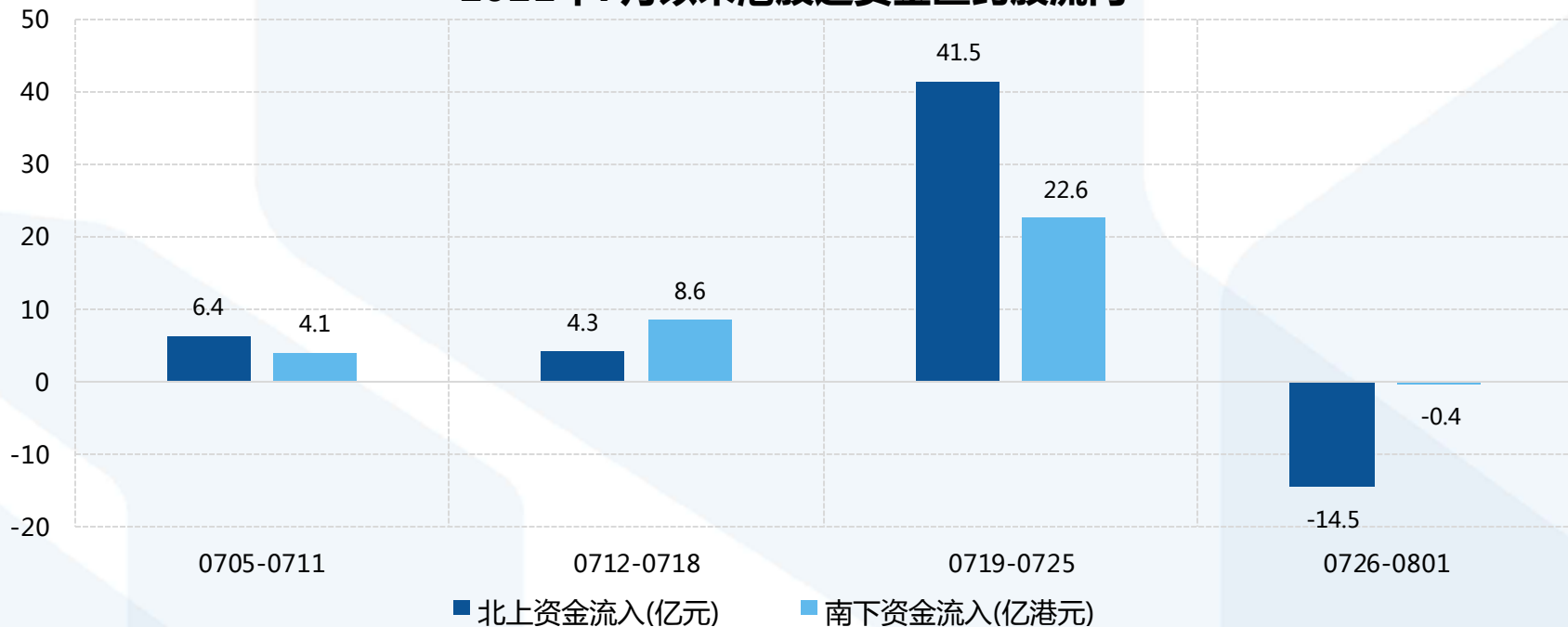
A股医药行业总市值8.18万亿，器械成为第一大子板块



数据来源：wind，国泰君安证券研究，数据截至2021-7-30
注：CXO的主要公司药明康德、泰格医药、康龙化成等均被sw行业分类计入医疗服务板块

7月波动之下，沪港深通资金在医疗板块仍为累计净流入

2021年7月以来港股通资金医药股流向

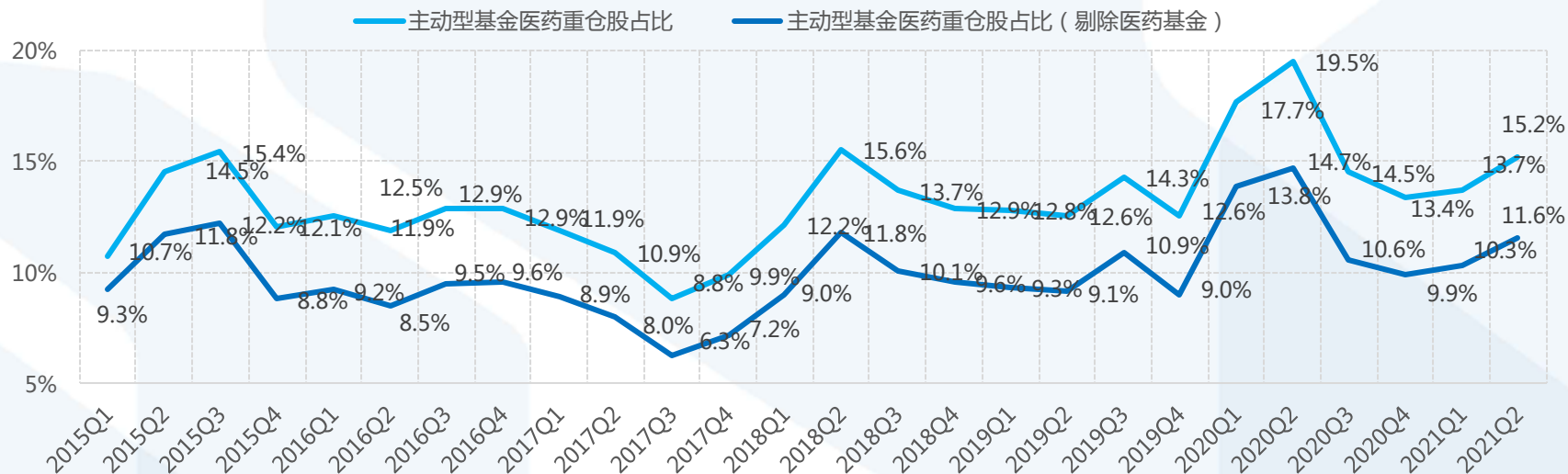


数据来源：Wind，港交所，国泰君安证券研究；注：交易所仅披露每日持股数量，资金流向系通过当日股价及持股数量变动估算

公募基金持仓：2021年Q2医药重仓股持仓占比环比上升1.49PP

- 2021年Q2主动型公募基金（样本为普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金）医药重仓股/总持仓的比例为15.2%，较2021年Q1上升1.49PP；扣除医药基金后为11.6%，较2021年Q1上升1.28PP。

主动型基金重仓医药股持仓统计



数据来源：wind，国泰君安证券研究。注：基金统计样本为wind普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金，只有年报和半年报基金才披露全部持股数据，季报只披露前10大重仓股。重仓医药股包括港股医药股。

2021Q2&2021Q1基金前十大医药重仓股（按持股基金数）

排名	2021Q2				2021Q1		
	股票代码	股票名称	持股基金数	持股基金数变动	股票代码	股票名称	持股基金数
1	603259.SH	药明康德	686	253	603259.SH	药明康德	433
2	300760.SZ	迈瑞医疗	449	36	300760.SZ	迈瑞医疗	413
3	300015.SZ	爱尔眼科	232	113	300015.SZ	爱尔眼科	119
4	000661.SZ	长春高新	226	-203	000661.SZ	长春高新	429
5	300122.SZ	智飞生物	215	-46	300122.SZ	智飞生物	261
6	300347.SZ	泰格医药	164	54	300347.SZ	泰格医药	110
7	600763.SH	通策医疗	137	53	600763.SH	通策医疗	84
8	002821.SZ	凯莱英	126	23	002821.SZ	凯莱英	103
9	600276.SH	恒瑞医药	123	-197	600276.SH	恒瑞医药	320
10	300759.SZ	康龙化成	99	28	300759.SZ	康龙化成	71

数据来源：wind，国泰君安证券研究，注：基金统计样本为wind开放式和封闭式股票型、混合型基金

2021Q2&2021Q1基金前十大医药重仓股（按持股市值）

排名	2021Q2				2021Q1		
	股票代码	股票名称	持股市值 (亿元)	季末总市值 (亿元)	股票代码	股票名称	持股市值 (亿元)
1	603259.SH	药明康德	672.2	4,596	603259.SH	药明康德	397.2
2	300760.SZ	迈瑞医疗	524.0	5,836	300760.SZ	迈瑞医疗	412.7
3	300015.SZ	爱尔眼科	332.8	3,837	300015.SZ	爱尔眼科	163.5
4	600763.SH	通策医疗	242.0	1,318	600763.SH	通策医疗	114.6
5	300122.SZ	智飞生物	196.3	2,988	300122.SZ	智飞生物	224.6
6	000661.SZ	长春高新	193.5	1,566	000661.SZ	长春高新	314.0
7	300347.SZ	泰格医药	189.4	1,635	300347.SZ	泰格医药	114.9
8	002821.SZ	凯莱英	134.1	904	002821.SZ	凯莱英	96.2
9	300759.SZ	康龙化成	131.8	1,664	300759.SZ	康龙化成	71.8
10	300363.SZ	博腾股份	94.0	458	300363.SZ	博腾股份	44.0

数据来源：wind，国泰君安证券研究，注：基金统计样本为wind开放式和封闭式股票型、混合型基金

行业 分类	公司 代码	公司 名称	现价 (元)	每股收益(元)				市盈率(X)				投资 评级
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
医疗器械	300760.SZ	迈瑞医疗	390.35	5.48	6.62	7.99	9.66	71	59	49	40	增持
研发外包	603259.SH	药明康德	150.00	1.00	1.56	2.11	2.84	150	96	71	53	增持
研发外包	603127.SH	昭衍新药	189.80	1.16	1.65	2.31	3.05	163	115	82	62	增持
研发外包	300347.SZ	泰格医药	157.60	2.01	2.26	2.66	3.14	79	70	59	50	增持
医疗服务	300015.SZ	爱尔眼科	58.70	0.32	0.44	0.59	0.79	184	133	99	75	增持
医疗服务	600763.SH	通策医疗	315.46	1.54	2.35	3.11	4.10	205	134	101	77	增持
医疗器械	300896.SZ	爱美客	648.81	2.03	3.22	4.82	6.75	319	201	135	96	增持
生物制品	300357.SZ	我武生物	60.01	0.53	0.66	0.85	1.12	113	91	71	54	增持
生物制品	300122.SZ	智飞生物	157.89	2.06	2.87	4.07	5.46	77	55	39	29	增持
生物制品	300601.SZ	康泰生物	127.00	0.99	1.48	2.53	3.60	128	86	50	35	增持
医疗器械	300633.SZ	开立医疗	26.73	-0.12	0.52	0.68	0.88	-	51	39	30	增持

风险提示

- 集采政策顶层框架设计已确定，在市场预期之内，如地方推进节奏较快则对相关公司业绩影响可能提前。
- 创新药立项、里程碑式研发进展不能保证产品能够获批，获批后的销售进度预期也有较大不确定性。
- 板块商誉较大，部分公司有减值风险。
- 疫情对相关公司的影响程度和时间不确定。



免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。